Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 32ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F:( )

Processo nº **0066332-38.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): P. G. D. S. P. B.
REPRESENTANTE: THIAGO FREIRE PINTO BEZERRA

RÉU: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

SENTENÇA COM FORÇA DE MANDADO

Vistos, etc.

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada **por Pedro Guerra da Silva Pinto Bezerra, menor impúbere de 13 anos, representado por seu genitor, Thiago Freire Pinto Bezerra, em face da Fundação CHESF de Assistência e Seguridade Social (FACHESF).**

O autor é beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, tendo sido diagnosticado em fevereiro de 2024 com **Puberdade Rapidamente Progressiva (CID 10: E30.8**). Conforme relatório médico, tal condição causa aceleração do processo normal de puberdade, tendo como principal sinal o avanço da idade óssea, **ocasionando o fechamento precoce das epífises de crescimento e prejudicando a altura final do adulto.**

Para tratamento da condição, a médica especialista em endocrinologia pediátrica prescreveu o uso de **hormônio do crescimento Omnitrope 15mg (2,9mg/dia, equivalente a 6 unidades/mês) associado ao inibidor de aromatase Anastrozol 1mg,** medicamentos que, segundo o laudo médico, constituem o único tratamento capaz de combater a enfermidade do autor.

Alega que, desde o início do tratamento em fevereiro de 2024, o prognóstico de altura do paciente aumentou de 176cm para 185cm, demonstrando a eficácia do tratamento, que deve ser mantido até que o autor atinja a idade óssea de 16 anos. Contudo, o custo mensal do tratamento é elevado, chegando a aproximadamente R$ 7.000,00, colocando em risco sua continuidade.

Os genitores do autor solicitaram administrativamente à ré o reembolso do tratamento, tendo recebido como resposta a negativa do fornecimento sob o argumento de ausência de cobertura contratual.

O autor sustenta que a negativa é abusiva, alegando que: a) não há exclusão contratual da doença; b) o tratamento requerido está previsto no Rol de Coberturas Mínimas da ANS; c) o medicamento é o único possível para combater a enfermidade conforme laudo médico. Ademais, argumenta que a interrupção do tratamento poderá acarretar danos irreversíveis, como depressão, problemas de interação social, retraimento, transtorno de ansiedade, comportamento agressivo e baixa autoestima.

Requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade na tramitação do feito por se tratar de autor menor. No mérito, pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar que a ré forneça/custeie o tratamento prescrito pela médica e, ao final, a confirmação da tutela antecipada e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Juntou documentos para comprovar suas alegações, incluindo laudo médico e negativa do plano de saúde. Deu à causa o valor de R$ 5.000,00.

Intimado para emendar o feito no que toca o valor atribuído à causa, bem como apresentar os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, a parte veio aos autos ao ID 212694381 apresentando o valor correto atribuído à causa, qual seja, R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e reiterando o pedido de gratuidade, sem, contudo, apresentar a documentação requerida dos responsáveis. Subsidiariamente, requereu a emissão da guia de custas iniciais.

Correção do valor atribuído à causa, gratuidade e liminar indefira indeferidas ao ID 213031947.

A Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social (FACHESF) apresentou contestação (ID 216094021) tempestiva impugnando o valor da causa de R$ 65.000,00 por considerá-lo excessivo e desprovido de justificativa, requerendo sua correção. Impugnou também o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, alegando que a mera declaração de hipossuficiência constitui presunção relativa que pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem ausência dos pressupostos legais. Manifestou-se ainda contrária à inclusão do feito no juízo 100% digital, exceto quanto às audiências, solicitando que as intimações sejam direcionadas exclusivamente ao painel do advogado Eric Castro e Silva.

No mérito, a contestante sustentou que, como entidade fechada de previdência complementar organizada sob o regime de autogestão e sem fins lucrativos, não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, razão pela qual requereu o afastamento da inversão do ônus da prova. Argumentou que a recusa administrativa em reembolsar os medicamentos Omnitrope (Somatropina) e Anastrozol encontra amparo legal no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, que permite a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados apenas os antineoplásicos. Destacou que o regulamento do plano Fachesf Saúde Premium contratado pelo autor reproduz fielmente essa exclusão legal, e que a Resolução Normativa 465/2021 da ANS também prevê idêntica restrição.

A defesa enfatizou que os medicamentos requeridos destinam-se a tratamento de Puberdade Rapidamente Progressiva mediante aplicações subcutâneas diárias em ambiente domiciliar, não se enquadrando nas exceções legais que obrigam a cobertura. Afirmou que o termo "Hormônio de Crescimento HCH" constante do rol da ANS refere-se a exame diagnóstico e não ao medicamento propriamente dito, inexistindo cobertura obrigatória para a somatropina. Invocou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Pernambuco reconhecendo a licitude da exclusão de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos.

Quanto aos danos morais pleiteados, alegou inexistir ato ilícito, uma vez que agiu no exercício regular de direito ao negar cobertura expressamente excluída por lei e contrato. Citou precedentes do STJ no sentido de que a mera recusa de cobertura, quando fundamentada em dúvida razoável ou previsão contratual, não configura dano moral indenizável. Subsidiariamente, caso reconhecido o dano moral, requereu sua fixação em patamar inferior ao postulado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, alertou que a concessão judicial de cobertura não prevista contratualmente acarretaria grave desequilíbrio econômico-financeiro da entidade de autogestão, comprometendo o mutualismo e a solidariedade que regem os planos fechados, com reflexos negativos sobre toda a coletividade de beneficiários. Requereu a total improcedência dos pedidos e a condenação do autor em custas e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

Ao ID 217285122 foi noticiado o deferimento da medida liminar em sede de recurso.

No ID 218012490 o plano réu apresentou o cumprimento da obrigação estabelecida na liminar.

Réplica apresenta ao ID 219401659 refutando as preliminares e impugnando a matéria da defesa, sem sede de novas provas.

Por sua vez, o plano réu na manifestação encartada ao ID 219409481 ressaltou a importância de perícia técnica para melhor auxiliar o juízo e pugnou pela improcedência do feito.

Manifestação do órgão ministerial ao ID 222550546 pronunciando-se pela procedência integral dos pleitos autorais.

Volveram-me conclusos.

É o que importa relatar.

Decido.

1. Do julgamento antecipado da lide.

O feito comporta julgamento antecipado, na forma do Art.355, I, do Diploma de Ritos. É que, compulsando os elementos produzidos pelas partes, se infere desnecessária a dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova documental apresentada. Eventual produção de prova oral ou pericial não terá o condão de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

A parte ré requereu, a nomeação de perito médico oficial para confirmar a existência da patologia, alegando, ainda, que o autor não trouxe exames suficientes para comprovar o diagnóstico.

Contudo, tal prova se revela desnecessária ao deslinde da controvérsia. O cerne da questão não é de ordem fática, mas sim de ordem puramente jurídica: saber se a operadora de saúde tem a obrigação legal e contratual de custear o medicamento prescrito (**hormônio do crescimento Omnitrope 15mg (2,9mg/dia, equivalente a 6 unidades/mês) associado ao inibidor de aromatase Anastrozol 1mg**), que é de uso domiciliar.

Mesmo que a perícia confirmasse o diagnóstico da exordial, a solução da lide dependeria da interpretação do contrato, da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções Normativas da ANS.

Encontra-se pacificado na doutrina e na jurisprudência que o julgador, visualizando nos autos elementos suficientes para a apreciação das questões postas pelas partes, pode dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, e julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (Theotônio Negrão. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 31ª Edição. São Paulo: Saraiva, p. 397).

Nessa diretiva, Cândido Rangel Dinamarco é preciso ao pontuar: "a razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do Art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento" (Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III. São Paulo: Malheiros, p.555).

Na mesma linha de raciocínio, o STF firmou entendimento de que "a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (STF - RE 101171, Relator Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984, p.20990). Para a Corte, "o propósito de produção de provas não obsta ao julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado (STF -RE 96725/RS, Rel. Min. Rafael Mayer).

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. 1. No sistema de persuasão racional adotado

pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, **não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção**. Desse modo, não há incompatibilidade entre o Art. 400 do CPC, que estabelece ser, via de regra, admissível a prova testemunhal, e o Art. 131 do CPC, que garante ao juiz o poder de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010).

PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA POSTULADA. REEXAME. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - **Sendo o magistrado destinatário final das provas produzidas, cumpre-lhe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, indeferindo as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias (CPC, Art.130, parte final).2- A mera alegação de haver o juízo sentenciante julgado antecipadamente a lide, com prejuízo da produção das provas anteriormente requeridas, não implica, por si só, em cerceamento de defesa**. 3- Indagação acerca da imprescindibilidade da prova postulada que suscita reexame de elementos fático-probatórios da causa (Súmula nº7). Precedentes do STJ. 4- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 1351403/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe29/06/2011).

Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ. REsp nº2.832-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, QUARTA TURMA). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

2. Das preliminares

2.1 Sobre a Impugnação à Concessão Da Gratuidade.

Preliminarmente, o réu impugnou a gratuidade da justiça concedida à parte autora.

Como é cediço, é relativa à presunção de pobreza que milita em favor daquele que afirma essa condição, o que permite ao Juiz considerá-la insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça sempre que a situação social, profissional ou patrimonial do requerente for incompatível com o benefício pleiteado.

Todavia, se o réu opôs impugnação à gratuidade por não concordar com o seu deferimento, atrai para si o ônus de provar que a parte beneficiária não faz jus ao benefício, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/2015.

No caso, o impugnante não trouxe qualquer prova apta a elidir a afirmação de pobreza feita pela impugnada e, assim, invalidar a decisão que lhe havia deferido o benefício da gratuidade de justiça. O fato da postulante encontrar-se acompanhada de advogados particular não elide a presunção de pobreza reconhecida inicialmente, sobretudo, quando é cediço que as partes podem pactuar que o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Entendimento pacificado no âmbito da jurisprudência do STJ.

Com essas razões, rejeito a preliminar.

2.2 Da impugnação ao valor da causa.

Não merece prosperar a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pela parte ré.

O valor atribuído à causa (R$ 65.000,00) encontra-se em perfeita consonância com o disposto no artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, que estabelece que, nas obrigações de trato sucessivo, o valor da causa corresponderá à soma de 12 (doze) prestações mensais.

No caso em tela, pleiteia-se o fornecimento de medicamento com custo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resultando no montante anual de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme critério legal

estabelecido. A este valor, soma-se a pretensão indenizatória por danos morais, estimada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalizando os R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) atribuídos à causa.

A metodologia utilizada não configura superestimação ou subfaturamento, mas sim estrita observância ao parâmetro objetivo estabelecido pelo legislador processual para hipóteses de obrigações continuadas, sendo irrelevante, para fins de valoração da causa, eventual tempo de duração superior a 12 meses.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios sobre a matéria.

Ante o exposto, requer seja **rejeitada** a preliminar de impugnação ao valor da causa, mantendo-se o montante originalmente atribuído.

3. Mérito

A controvérsia dos autos reside em definir a legalidade da negativa de cobertura de medicamentos prescritos pelo médico assistente (Omnitrope - Somatropina e Anastrozol), bem como se da negativa administrativa resultou dano extrapatrimonial indenizável.

A matéria trazida aos autos deve ser dirimida à luz dos parâmetros estabelecidos na Súmula nº 608 do C. STJ, segundo a qual "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.04.2018, DJe 17.04.2018; na mesma oportunidade, cancelou-se a Súmula nº 469).

Uma vez que a empresa requerida foi constituída sob a modalidade de autogestão, não se aplica ao caso a legislação consumerista, devendo a solução da lide ser informada pelas disposições contratuais e pela legislação específica dos planos de saúde.

Consoante entendimento consolidado pelo STJ, "A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de

saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). No mesmo sentido: "Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual." (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Nessa diretiva, é certo que a Lei nº 9.656/98 traçou exigências mínimas para o fornecimento de medicamentos pelas operadoras de planos de saúde. Com efeito, o artigo 10 da Lei dos Planos de Saúde excetua, nos incisos V e VI, o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos. Por sua vez, o artigo 12 inclui dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Eis a redação do art. 10, incisos V e VI, da Lei de Planos de Saúde:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento

domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (...) § 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS."

Ampliando a cobertura prevista no Art. 10, o Art. 12 consignou:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;

Regulamentando a legislação federal neste aspecto particular, a Resolução Normativa (RN) nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conceituou medicamento importado não nacionalizado como aquele produzido fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por seu turno, medicamento de uso domiciliar, segundo o ente regulador, é aquele prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. A propósito, confira-se a redação do art. 17, parágrafo único, V e VI, da RN nº 465/2021 da ANS:

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: (...) V - fornecimento de medicamentos e produtos para a

saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13."

A exclusão da assistência farmacêutica para o medicamento importado sem registro na ANVISA encontra fundamento nas normas de controle sanitário. Isso porque a importação de medicamentos e outras drogas, para fins industriais ou comerciais, sem a prévia e expressa manifestação favorável do Ministério da Saúde constitui infração de natureza sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei nº 6.360/1976 e 10, IV, da Lei nº 6.437/1977), não podendo a operadora de plano de saúde ser obrigada a custeá-los em afronta à lei (vide REsp nº 874.976/MT, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009). Nesse sentido, os seguintes enunciados da I Jornada de Direito da Saúde, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

"Enunciado nº 6 A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei."

"Enunciado nº 26 É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental."

De todo o arrazoado, portanto, colhe-se ser lícito que se exclua o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar - administração em ambiente externo ao de unidade de saúde -, salvo os antineoplásicos, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, bem como os serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente.

A vedação constante no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, voltada à operadora de plano de saúde, não obsta que, na contratação, atendidos os requisitos regulatórios, as partes incluam dentre as coberturas obrigatórias os medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade. Ademais, é possível a contratação acessória de cobertura de medicamentos domiciliares, de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.

No caso dos autos, extrai-se que os medicamentos postulados (Omnitrope - Somatropina e Anastrozol), indicados para o tratamento da patologia catalogada no CID E30.8 (Puberdade Rapidamente Progressiva), não podem ser classificados como antineoplásicos e sua administração, restou incontroverso nos autos, ocorre em ambiente domiciliar mediante aplicações subcutâneas diárias.

E, considerado que não há no contrato principal previsão acerca da obrigatoriedade de cobertura de medicamentos domiciliares, bem como que não há notícias de contratação acessória, nos termos da RN 310/2012, tem-se que descabe a imposição de cobertura à operadora do plano de saúde, em atenção ao previsto no pacto e na legislação de regência.

Importante consignar que nos casos em que o direito da parte esbarra nas disposições livremente pactuadas, as partes ainda podem se valer do Sistema Único de Saúde - SUS, que promove assistência farmacêutica em atenção à Política Nacional de Medicamentos (PNM) por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

Nesse sentido, segue recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO

CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).

Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).
Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
A previsão legal do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS.
No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
Recurso especial provido. (REsp XXXX/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Sendo assim, verifica-se que a operadora do plano de saúde não tem o dever de cobertura dos medicamentos postulados.

E considerando que inexiste no presente caso ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde, descabe cogitar acerca da imposição do dever indenizatório.

4. Dos Efeitos Da Sentença De Improcedência Sobre a Tutela de Urgência.

O entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre o tema vem se formando no sentido de que a sentença de improcedência revoga os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida independentemente de manifestação expressa. Isso significa dizer que, naturalmente, haverá

a revogação da tutela antecipada - tenha ela sido deferida pelo juízo prolator da sentença ou na via recursal - pela superveniente sentença de improcedência, podendo essa revogação ser expressa ou tácita.

Nesse sentido são os ensinamentos de José Roberto Bedaque:

"Mesmo que omissa a sentença sobre a revogação do provimento concessivo da antecipação, deve-se entender existente ordem implícita nesse sentido. É exatamente o que se verifica em relação a sentença favorável ao autor de demanda cautelar autônoma, se improcedente a pretensão principal. Haverá cessão de eficácia da medida de urgência, que estava condicionada ao deferimento da tutela definitiva no processo de conhecimento (...)

Deverá o juiz, portanto, julgar improcedente o pedido principal e cassar os efeitos antecipados. Nesse aspecto, estará decidindo sobre a pretensão antecipatória, revogando-a. Tal capítulo de sentença versa apenas a tutela antecipada, cuja natureza é cautelar, aplicando-se, portanto, o disposto no Art. 520, IV, do Código de Processo Civil. Possível invocar ainda o inciso VII do mesmo dispositivo, previsto para situação análoga.

Irrelevante eventual omissão do julgador quanto à cessação dos efeitos anteriormente antecipados. Essa consequência é automática". (In "Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência (tentativa de sistematização) ", 5ª edição, Malheiros, pp. 432/433).

Em convergência, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTRO DO TRABALHO E EMPREGO. REGISTRO PROFISSIONAL. JORNALISMO. **ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. EFEITO IMEDIATO E EX TUNC.** SÚMULA 405/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 1. Não tem direito líquido e certo ao registro de jornalista quem o obteve, em caráter precário, por força de antecipação de tutela exarada nos autos de ação civil pública. Decisão confirmada pela sentença, mas reformada em apelação. 2. **A improcedência da demanda implica a revogação**

da medida antecipatória com eficácia imediata e ex tunc. É de se aplicar, por analogia, o enunciado da Súmula 405/STF, de seguinte teor: "denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária". 3. Precedente da Seção: AgRg no MS 11.798/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 04.09.06. 4 Segurança denegada. (MS 11.812/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2006, DJ 27/11/2006, p. 222)

Essa conclusão é decorrência lógica da própria finalidade da tutela antecipada que, fundada em um juízo de probabilidade, visa a garantir a efetividade do provimento final. Assim, com base em uma cognição superficial sobre o direito do autor, o sistema processual permite que sejam concedidos antecipadamente os efeitos pretendidos com a tutela jurisdicional definitiva, nas hipóteses em que a demora do processo represente risco de dano.

Uma vez realizada a cognição exauriente, da qual resulte o julgamento desfavorável ao pedido do autor, afasta-se a probabilidade antes vislumbrada, de modo a tornar insubsistente requisito essencial à manutenção da tutela antecipada deferida, e, por via de consequência, a acarretar a sua revogação automática com a prolação sentença de improcedência.

Na hipótese de o deferimento da tutela antecipatória ter imputado à parte demandada obrigações que acarretaram despesas, incumbirá à parte que se beneficiou indenizar os danos ou dispêndios por ela suportados.

Consoante entendimento firmado no âmbito do E. STJ "**a sentença de improcedência, quando revoga tutela concedida por antecipação, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será**

posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. ” (REsp 1.548.749/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 6/6/2016).

Para a Corte, “**a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, inclusive, pedido da parte interessada**”. (STJ - REsp: 1767956 RJ 2018/0037521-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).

Posto isto, forçoso reconhecer que a autora deverá indenizar a ré pelos valores comprovadamente despendidos com o cumprimento da medida antecipatória deferida incidentalmente, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

Posto isto, com arrimo nos fundamentos fáticos e jurídicos ora explicitados, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos formulados na vestibular, razão por que **CONDENO** a parte autora ao pagamento das custas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a regra do Art. 98, §3º, do CPC, na hipótese de lhe ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça.

REVOGO a medida liminar anteriormente deferida em sede recursal.

No caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (inclusive voltados à mera rediscussão do julgado), aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Interposta a apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC, que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal.

Publique-se e intimem-se.

Certificado o trânsito, arquivem-se os autos definitivamente.

Via eletronicamente assinada servirá como expediente de comunicação processual.

Recife (PE), 27 de novembro de 2025.

José Júnior Florentino dos Santos Mendonça

Juiz de Direito

4

Assinado eletronicamente por: JOSE JUNIOR FLORENTINO DOS SANTOS MENDONCA
28/11/2025 12:32:59
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 224289084

25112812325928400000218239057

IMPRIMIR GERAR PDF